혈압 두 숫자가 엇갈릴 때

단독 수축기·이완기고혈압 접근

김대희 연자 강의 · 의료진 학습 덱

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

높은 숫자 하나도 진료의 출발점이다

측정 → 진료실 밖 혈압 → 원인 → 위험·내약성

1 측정 재확인

적절한 커프·청진법으로 SBP와 DBP를 직접 확인한다.

→

2 실제 패턴

가정혈압/ABPM으로 백의·가면 효과를 구분한다.

→

3 원인 탐색

넓거나 좁은 맥압, 동반 질환과 생활·약물 요인을 본다.

→

4 개별 조절

전체 심혈관 위험, 기립 증상, 노쇠와 다른 혈압 숫자를 함께 본다.

임상 포인트 · 측정 → 진료실 밖 혈압 → 원인 → 위험·내약성

넓은 맥압과 좁은 맥압의 단서

맥압 = 수축기혈압 − 이완기혈압

넓은 맥압

- 고령에서 대동맥 경직이 흔하며 당뇨·CKD에서도 관찰된다.
- 대동맥판역류, 갑상선기능항진증, 빈혈, 동정맥루, 발열·운동 직후를 감별한다.
- 확장기 잡음 또는 맥압 약 100 mmHg이면 echo를 검토한다.

매우 좁은 맥압

- SBP 100대 초반·DBP ≥90이면 차이가 10~20 mmHg일 수 있다.
- 커프·부정맥·진동법 알고리즘의 오차를 먼저 배제한다.
- 드물게 중증 대동맥판협착·저박출 상태를 고려한다.

임상 포인트 · 맥압 = 수축기혈압 − 이완기혈압

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

다시 재기 전, 측정 조건부터 맞춘다

강의의 진료실 혈압 측정 교육

1 준비

30분 전 흡연·음주·카페인 금지, 배뇨 후 측정.

→

2 안정

조용한 곳에서 최소 5분. 연자는 5~10분 또는 10분 교육을 설명.

→

3 자세

등·발 지지, 다리 꼬지 않기, 맨팔 커프를 심장 높이에.

→

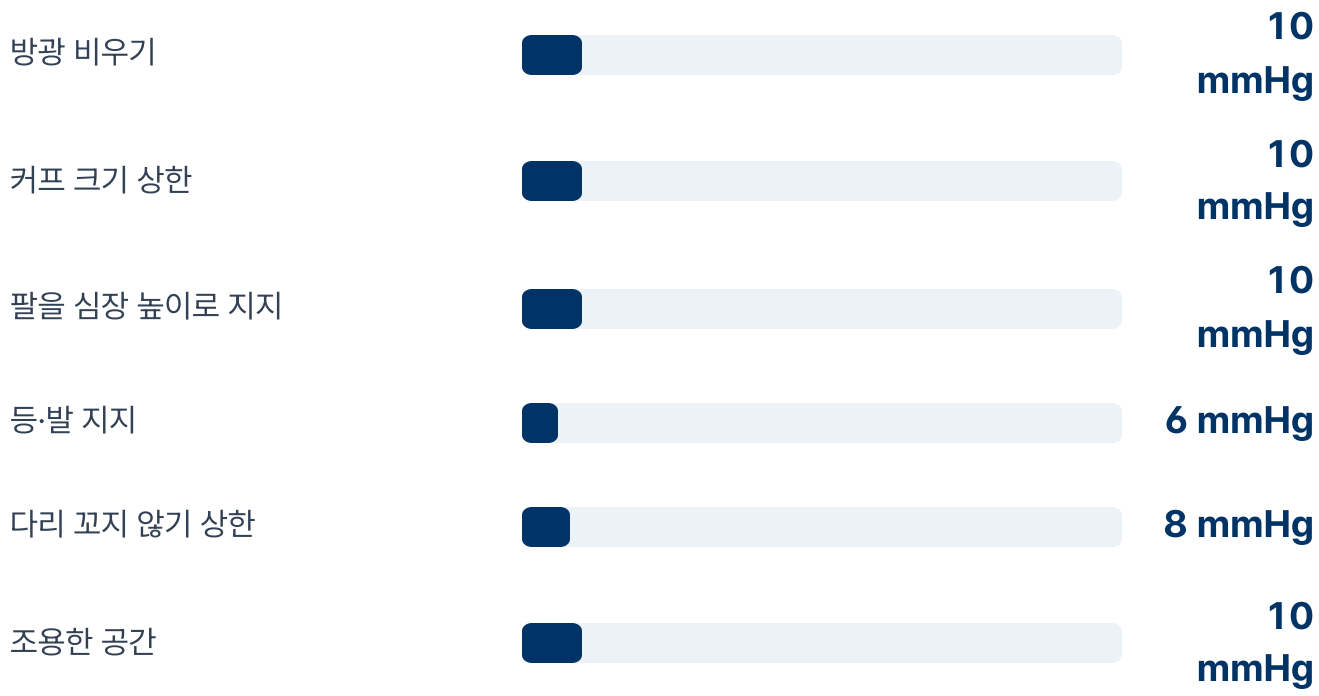
4 반복

대화·휴대폰 없이 ≥30초 간격 재측정 평균과 맥박 규칙성 확인.

임상 포인트 · 강의의 진료실 혈압 측정 교육

커프와 자세는 혈압 분류를 바꿀 수 있다

강의의 준비 단계별 잠재적 SBP 영향



해석의 맥락

표의 커프 크기 영향은 2~10, 맨팔 커프는 5~50 mmHg 범위였다. 강의 예시의 동일 여성 혈압은 표준 106/66, 대형 96/66, 소형 114/72 mmHg였다.

그래프는 개별 항목의 제시값이다. 서로 더해 실제 혈압 변화량으로 예측하지 않는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

진료실 밖 혈압으로 phenotype을 구분한다

치료 전과 치료 중에 사용하는 명칭도 다르다

진료실 / 밖 혈압	치료 전	치료 중
높음 / 높음	지속성 고혈압	비조절 고혈압
높음 / 정상	백의고혈압	백의 비조절·백의효과
정상 / 높음	가면고혈압	가면 비조절 고혈압
정상 / 정상	정상 범주	조절 고혈압

강의의 기준: 진료실 140/90, 주간 135/85, 24시간 130/80 mmHg. 진료실 130~139에서도 가면 비조절을 고려.

측정은 한 번의 최고값보다 평균과 패턴으로

강의의 가정혈압 교육과 연자 Q&A를 구분해 적용한다

강의의 교육 방식

검증된 위팔 자동혈압계. 아침 기상 1시간 이내·배뇨 후·식전·복약 전, 저녁 취침 전. 30초 간격 3회씩, 외래 전 5~7일을 교육했다.

변동이 클 때 — 연자 Q&A

기기를 가져와 청진법과 비교하고 실제 측정 모습을 본다. 5~7일 아침저녁 2회씩, 첫날 제외 평균을 제시했다. 아침·저녁 평균을 나누어 본다.

변동의 원인

AF·기외수축, 기립성·식후 저혈압, 자율신경병증, 수면무호흡, 음주·진통제를 살핀다. 지속 변동 시 ABPM으로 패턴을 확인한다.

임상 포인트 · 강의의 가정혈압 교육과 연자 Q&A를 구분해 적용한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

SBP가 높고 DBP가 낮을 때

연자 Q&A가 설명한 노인 수축기단독고혈압의 조절

하한과 증상

Q&A는 DBP ≥60 mmHg 범위에서 SBP <140 mmHg를 제시했다. 60~70 구간에서는 어지럼·기립성 저혈압·협심증을 본다.

고위험군

관상동맥질환 가능성이 높은 노인, 재관류되지 않은 다혈관질환, 당뇨·심비대에서는 DBP <70 mmHg로 낮추지 않는 것을 고려한다고 설명했다(권고 18, IIb, B).

낮은 DBP만으로 포기하지 않기

연자가 소개한 SPRINT 사후분석은 기저 DBP 최저 5분위(평균 61 mmHg)에서도 적극 SBP 조절의 이득이 다른 군과 다르지 않았다는 설명이다.

임상 포인트 · 연자 Q&A가 설명한 노인 수축기단독고혈압의 조절

SBP만 선택적으로 낮추는 약은 없다

수축기단독고혈압의 약제와 조정 속도 — 연자 Q&A

근거가 제시된 계열

- 티아지드·티아지드유사 이뇨제: SHEP의 chlorthalidone, HYVET의 indapamide.
- 장시간 DHP-CCB: Syst-Eur의 nitrendipine. RAS 억제제도 일차 약제로 사용한다.
- 염분 감수성이 높은 노인에서는 저염식의 효과가 크다.

내약성을 보며 조절

- 노인은 젊은 성인 절반 용량으로 시작, 2~4주 간격의 느린 증량을 설명했다.
- 혈관확장 작용 없는 BB는 별도 적응증이 없으면 피하도록 했다.
- DBP·기립 증상·낙상 위험을 보며 기존 조합에서 빠진 계열을 검토한다.

임상 포인트 · 수축기단독고혈압의 약제와 조정 속도 — 연자 Q&A

160/60 mmHg라면, 확인하고 천천히 낮춘다

70세 이상 환자에 대한 연자 Q&A의 접근

1

실제 SBP

가정혈압/ABPM으로 백의효과를 확인.

→

2

맥압 100

기립 혈압·잡음·echo, 갑상선항진·빈혈 감별.

→

3

낮은 용량

장시간 DHP-CCB·티아지드 계열, 2~4주 간격 조정.

→

4

우선 <150

잘 견디면 <140. DBP <60 또는 어지럼·협심증·기립저혈압 시 더 낮추지 않음.

노쇠 동반 시 목표 개별화(연자 Q&A, IIb, C). 이 예시를 모든 노인에게 같은 목표로 적용하지 않는다.

가성고혈압은 정황으로 의심하고 확진을 구분한다

연자 Q&A: 의원의 커프 측정만으로 확진하기는 어렵다

의심하는 상황

높게 측정되지만 LVH·망막병증·알부민뇨 같은 장기 손상이 없고 약을 조금만 늘려도 어지럼·실신이 생긴다.

배경

장기간 당뇨·CKD와 심한 혈관 석회화가 있는 고령자에서 가능성을 생각한다.

오차 공유

가정혈압과 활동혈압도 커프를 사용하므로 같은 오차를 공유할 수 있다. 정상·비정상을 가르는 단독 확진법으로 두지 않는다.

확진과 징후

확진은 침습적 동맥압 측정이다. Osler 징후는 재현성이 낮아 판단 근거로 삼기 어렵다고 설명했다.

임상 포인트 · 연자 Q&A: 의원의 커프 측정만으로 확진하기는 어렵다

이완기단독고혈압: 확인 후 위험에 따라 시작

120/95 mmHg에 대한 연자 Q&A

1 측정

맥압 25 mmHg: 커프·청진법으로 재확인하고 진료실 밖 혈압을 본다.

→

2 저위험

3개월 체중·절주·저염·운동·수면무호흡 관리 후 지속 여부를 본다.

→

3 위험이 높으면

당뇨·CKD·장기 손상·위험인자 ≥3이면 생활요법과 약물 병행.

→

4 치료 관찰

SBP <100 mmHg·기립 어지럼 여부를 보며 저용량부터 조정.

임상 포인트 · 120/95 mmHg에 대한 연자 Q&A

젊은 DBP 상승: 생활·이차성 원인과 약제

연자의 순서를 설명한 Q&A이며 심박수 하나로 자동 처방하지 않는다

원인과 생활요인

복약·복용 시각, 비만·음주·흡연·카페인·수면무호흡, 감기약·NSAID를 확인한다.

젊은 난치성 고혈압에서는 일차성 알도스테론증, 갑상선저하·콩팥질환을 살핀다.

한쪽만 기준을 넘더라도 고혈압 분류에 해당한다고 설명했다.

약제 조정 — 연자 Q&A

RAS 억제제를 우선하고, 안정시 HR >80이면 BB를 고려하는 접근을 제시했다.

이후 CCB, 필요시 알파차단제; 난치성이면 알도스테론증 선별 후 MRA를 검토했다.

SBP 110~120에서 추가 시 <100 또는 기립 증상을 본다. DBP 목표 <90, 고위험 <80 mmHg로 설명했다.

임상 포인트 · 연자의 순서를 설명한 Q&A이며 심박수 하나로 자동 처방하지 않는다

연령 외에 기능과 노쇠를 평가한다

강의에 소개된 JSH 2025의 기능 상태 중심 목표

기능 상태	강의에 제시된 목표
ADL·IADL 독립	<130/80 mmHg
IADL 저하	SBP <140 mmHg
ADL 저하	SBP <150 mmHg
말기·중증 노쇠	SBP 140~160 mmHg에서 개별화

강의의 ESC 2024 비교: 18~84세 120~129, 85세 이상 <140 mmHg. 지침별 맥락과 내약성을 함께 읽는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

한쪽 혈압만 남는 외래의 마지막 점검

증량 전에 측정·원인·위험·증상을 다시 연결한다

측정

청진법·커프·부정맥, 집 기기와의 차이를 살핀다.

진료실 밖

백의·가면 효과를 구분하고 개별 최고값 대신 평균을 본다.

맥압

넓으면 AR·동맥경직, 매우 좁으면 측정오차·저박출 단서를 본다.

SBP 상승

DBP와 기립 증상을 보며 저용량·느린 증량을 시행한다.

DBP 상승

생활·이차성 원인과 전체 위험도에 따라 생활요법·약물을 정한다.

개별 목표

CAD·당뇨·CKD·기능·노쇠와 내약성을 반영한다.

임상 포인트 · 증량 전에 측정·원인·위험·증상을 다시 연결한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

강의에서 진료로

단독 수축기·이완기고혈압 접근

광교바른내과

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호

HOURS

평일(월–금) 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

CLINICIAN LEARNING

강의 내용 다시 보기

의료진 학습자료

혈압 두 숫자가 엇갈릴 때: 단독 수축기·이완기고혈압 접근